



GUIA PARA PACIENTES

Teste da cadeira de 30 segundos

+ 3 exercícios de equilíbrio pra fazer em casa

Um teste simples, usado no mundo inteiro, para ver a força das pernas, e três exercícios com apoio que ajudam a prevenir quedas.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **CADEIRA**

Para quem é:

Para pessoas com **60 anos ou mais** que andam sozinhas, com ou sem bengala, e para **filhos, netos e cuidadores** que querem acompanhar a força e o equilíbrio de quem amam.

Para quem NÃO é (sem antes falar com o médico):

- Quem caiu nas últimas semanas e ainda tem dor, ou bateu a cabeça.
- Quem tem **tontura** ao levantar, desmaios ou falta de ar com pouco esforço.
- Quem operou **quadril, joelho ou coluna** há pouco tempo.
- Quem tem dor forte no joelho ou no quadril ao levantar da cadeira.
- Quem não consegue levantar da cadeira **sem usar as mãos**: o teste para aí (Página 5), e a avaliação vem antes dos exercícios.

O que tu vais precisar:

- Uma **cadeira firme, sem rodinhas e sem braços**, com assento de uns 43 cm de altura (a altura comum de cadeira de mesa).
- Uma **parede** para encostar a cadeira.
- Um relógio ou celular para marcar 30 segundos.
- **Outra pessoa por perto.**
- Uma caneta para o registro da Página 8.

Regra de ouro:

Fazer com **apoio por perto e devagar**: sim.

Tontura, dor no peito ou falta de ar: **pare na hora**.

Leia esta página antes de fazer o teste ou os exercícios.

Antes de começar

- **Cadeira encostada na parede**, para não escorregar para trás.
- **Alguém por perto**, em pé ao lado, pronto para segurar. A própria ficha oficial do teste pede isso a quem aplica [1].
- **Calçado fechado** e firme, com sola de borracha. Nada de chinelo, meia sem sapato ou pé descalço em piso liso.
- Piso **seco**, sem tapete solto e sem fio no caminho.
- Uma **bancada firme ou o encosto de outra cadeira pesada** à frente, para segurar nos exercícios.
- Óculos no rosto, se usa.

Pare na hora e procure atendimento se aparecer:

- **Dor no peito**, falta de ar forte ou coração disparado.
- **Tontura**, visão escura ou sensação de desmaio.
- Dor forte e súbita no joelho, no quadril ou nas costas.

Procure o pronto-socorro HOJE se:

- Houve uma **queda com batida na cabeça**, principalmente em quem usa remédio para "afinar o sangue".
- Depois de uma queda, a pessoa **não consegue apoiar a perna** ou a perna ficou **mais curta ou virada para fora** (pode ser fratura do fêmur).

Quedas são comuns

Pelo menos **1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos** que vivem em casa cai a cada ano [3]. A queda pode levar a fratura, medo de andar e perda da independência.

Força das pernas e equilíbrio

Levantar da cadeira exige **força nas coxas e no quadril**. O teste de 30 segundos foi estudado em idosos que vivem em casa: ele se relacionou bem com a força das pernas medida em aparelho de academia e teve resultados parecidos quando repetido em outro dia [2]. Os resultados caem com a idade e são menores em quem é menos ativo [2].

O exercício previne quedas

Uma revisão Cochrane reuniu **108 estudos com 23.407 pessoas** de 60 anos ou mais vivendo em casa [3]:

- O exercício **reduziu as quedas em 23%** (certeza alta da evidência).
- Os exercícios de **equilíbrio e funcionais**, como levantar da cadeira e treinar ficar em pé com menos apoio, reduziram as quedas em **24%**.
- Programas que juntam equilíbrio com fortalecimento **provavelmente** reduzem ainda mais.

O que o teste NÃO é

Ele **não diagnostica** doença e **não substitui** a avaliação. É uma **régua simples** para acompanhar a força ao longo do tempo e saber quando conversar com o médico (opinião clínica).

Do jeito da ficha oficial do programa **STEADI**, do CDC, a agência de saúde pública dos Estados Unidos [1]:

1. A pessoa **senta no meio da cadeira**.
2. **Cruza os braços sobre o peito**, com as mãos nos ombros opostos.
3. **Pés apoiados no chão** e costas retas.
4. Ao ouvir "**Já!**", ela **fica de pé por completo** e senta de novo.
5. Repete o mais que conseguir, **por 30 segundos**, sempre com segurança.

Como contar

- Conte cada vez que ela **ficar totalmente de pé**.
- Se no fim dos 30 segundos ela estiver **mais da metade do caminho** para ficar de pé, conte essa também [1].
- Se ela **precisar usar as mãos** para levantar, **pare o teste** e anote **zero** [1]. Zero não é "reprovação": é sinal de que vale conversar com o médico antes de seguir.

Dicas práticas (orientação prática)

- Faça uma tentativa de treino, devagar, antes de valer.
- O objetivo é **segurança**, não recorde. Correr e "desabar" na cadeira não vale.
- Repita o teste **uma vez por mês**, na mesma cadeira e no mesmo horário, para comparar.

A ficha do CDC traz os valores **abaixo da média** para cada idade.

Resultado abaixo destes números indica risco de queda [1]. Os valores vêm do trabalho de Rikli e Jones com idosos que vivem em casa, o Senior Fitness Test [4][5].

Abaixo da média é:

Idade	Homens	Mulheres
60 a 64	menos de 14	menos de 12
65 a 69	menos de 12	menos de 11
70 a 74	menos de 12	menos de 10
75 a 79	menos de 11	menos de 10
80 a 84	menos de 10	menos de 9
85 a 89	menos de 8	menos de 8
90 a 94	menos de 7	menos de 4

Fonte: CDC, STEADI, 30-Second Chair Stand [1].

Exemplo

Dona Maria, 72 anos, levantou **9 vezes**. Para mulheres de 70 a 74 anos, abaixo da média é menos de 10. Então o resultado dela está **abaixo da média** e vale conversar com o médico (Página 11), além de começar os exercícios com apoio.

Cuidado com a leitura

- As normas foram feitas com idosos americanos. Elas servem de **referência**, e não de nota (opinião clínica).
- Um resultado **na média ou acima** é bom sinal, mas **não garante** que a pessoa não vá cair. Remédios, visão, tontura e a casa também contam.
- O mais útil é **comparar a pessoa com ela mesma**, mês a mês (Página 8).

*A escolha destes três é opinião clínica. São exercícios de equilíbrio e funcionais, o tipo que mais reduziu quedas na revisão Cochrane [3].
Sempre com uma bancada firme à frente e alguém por perto no começo.*

Exercício 1 — Sentar e levantar com controle

Como fazer: na cadeira encostada na parede, levante devagar e sente devagar, contando 3 segundos para descer. Se precisar, use as mãos nos joelhos ou no assento no início. 2 séries de 5 a 10, 1 vez ao dia.

Sensação correta: esforço nas coxas.

Erro comum: "cair" sentado na cadeira.

Exercício 2 — Ficar na ponta dos pés

Como fazer: em pé, de frente para a bancada, segurando com as duas mãos. Suba devagar na ponta dos pés, segure 2 segundos e desça devagar. 2 séries de 10.

Sensação correta: esforço na batata da perna.

Erro comum: soltar as mãos cedo demais.

Exercício 3 — Um pé na frente do outro

Como fazer: de frente para a bancada, segurando com as duas mãos. Coloque um pé **logo à frente do outro**, o calcanhar encostando nos dedos, como se estivesse numa corda. Fique 10 segundos. Troque o pé da frente. 3 vezes de cada lado.

Progressão: segurar com uma mão só; depois só com a ponta dos dedos; depois ficar **num pé só**, sempre ao lado da bancada.

Erro comum: fechar os olhos ou tirar as mãos sem ninguém por perto.

Semana 1 — Conhecer

- Faça o teste (Página 5) e anote o resultado.
- Exercícios 1, 2 e 3 com as **duas mãos** na bancada, 3 a 5 dias na semana.

Semanas 2 e 3 — Firmar

- Mais uma série em cada exercício, se estiver fácil e sem dor.
- No exercício 3, tente segurar com **uma mão só**.

Semana 4 — Avançar com cuidado

- Exercício 1 com menos ajuda das mãos.
- Exercício 3 com a ponta dos dedos na bancada, ou num pé só, **com alguém por perto**.
- Repita o teste e compare.

Os volumes e a progressão são um ponto de partida prático, não um protocolo testado. Na revisão Cochrane, os programas eram feitos de forma regular e por semanas a meses [3]: o ganho vem da constância.

Registro

	Teste da cadeira (nº)	Dias de exercício na semana	Teve tontura? (S/N)	Teve queda? (S/N)	Mãos no exercício 3 (2 / 1 / dedos)
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Mês 2					
Mês 3					

Leve esta tabela para a consulta.

Durante o teste e os exercícios

- Fique **em pé, ao lado**, um pouco atrás, com as mãos prontas, sem segurar o tempo todo.
- **Não puxe pelo braço** para levantar. Se precisar ajudar, apoie pela cintura (opinião clínica).
- Conte as repetições em voz alta: ajuda no ritmo e na confiança.

Em casa, no dia a dia (orientação prática)

- **Luz acesa** no caminho do quarto ao banheiro à noite.
- **Tapete solto fora**. Fios e objetos fora do caminho.
- **Barra de apoio** no banheiro e tapete antiderrapante no box.
- Coisas de uso diário em altura fácil, sem precisar subir em banco.
- Calçado fechado e firme, também dentro de casa.

Observe e anote

- Tropeços, quase-quedas, medo de andar.
- Tontura ao levantar da cama ou da cadeira.
- Piora no teste da cadeira de um mês para o outro.

Tudo isso é informação valiosa para a consulta.

1. Fazer o teste numa cadeira de rodinhas ou solta.

A cadeira precisa ser firme, sem braços e encostada na parede (Página 3).

2. Fazer sozinho.

A ficha oficial pede que alguém fique ao lado [1].

3. Usar o resultado como diagnóstico.

O teste é uma régua de força e de risco, não um exame. Quem decide a conduta é a consulta (opinião clínica).

4. Fazer só caminhada e achar que basta.

Na revisão Cochrane, o efeito da caminhada sozinha sobre as quedas foi **incerto**. O que mais reduziu quedas foram os exercícios de **equilíbrio e funcionais** [3].

5. Parar depois de duas semanas.

O benefício veio de programas mantidos por semanas a meses [3]. Faça disso um hábito, como escovar os dentes.

Bônus: chinelo e meia em piso liso.

Calçado fechado e firme, sempre.

Procure avaliação se:

- O resultado ficou **abaixo da média** para a idade (Página 6), ou foi **zero** porque precisou das mãos.
- Houve **uma queda** no último ano, ou mais de uma.
- A pessoa tem **medo de cair** e está andando menos por isso.
- Tem **tontura**, desequilíbrio novo ou fraqueza de um lado do corpo. Fraqueza súbita de um lado ou fala enrolada: **pronto-socorro na hora**.
- Usa **muitos remédios**, principalmente para dormir, pressão ou ansiedade: vale revisar com o médico.
- O teste **piorou** de um mês para o outro.
- Dor no joelho ou no quadril atrapalha levantar da cadeira.

Se quiser uma avaliação

A consulta olha **o todo**: força, equilíbrio, marcha, remédios, visão, ossos e a casa. O programa STEADI do CDC foi criado justamente para ajudar profissionais a **rastrear, avaliar e intervir** no risco de queda [1].

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). **STEADI — Assessment: 30-Second Chair Stand**. Atlanta: CDC; 2017. Disponível em: <https://www.cdc.gov/steady/media/pdfs/STEADI-Assessment-30Sec-508.pdf> · Programa STEADI: <https://www.cdc.gov/steady/>
2. Jones CJ, Rikli RE, Beam WC. **A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults**. Res Q Exerc Sport. 1999;70(2):113-119. doi:10.1080/02701367.1999.10608028. PMID: 10380242.
3. Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, et al. **Exercise for preventing falls in older people living in the community**. Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD012424. doi:10.1002/14651858.CD012424.pub2. PMID: 30703272.
4. Rikli RE, Jones CJ. **Functional fitness normative scores for community-residing older adults, ages 60-94**. J Aging Phys Act. 1999;7(2):162-181. (Revista não indexada no PubMed nesse ano; sem PMID.)
5. Rikli RE, Jones CJ. **Development and validation of criterion-referenced clinically relevant fitness standards for maintaining physical independence in later years**. Gerontologist. 2013;53(2):255-267. doi:10.1093/geront/gns071. PMID: 22613940.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765